示例成人高血压管理指南（2026 版）

mkbAI 演示用合成文本 · 不是任何真实学会的出版物 · 数值为编造，不可用于临床

本文件由项目自带，目的是让没有 API key 的人也能把「入库 → 检索 → 闸门 → 引用溯源」整条链路点开看。 文中所有界值、目标值、随访周期都是虚构的示例数字。

一、血压水平的定义与分类

在未使用降压药物的情况下，非同日三次诊室血压测量均达到收缩压 140 mmHg 和/或舒张压 90 mmHg，方可考虑高血压的诊断方向。收缩压 120~139 mmHg 且舒张压 80~89 mmHg 记为正常高值血压，这部分人群一年内转为高血压的比例在本示例模型中约为 21%。

家庭自测血压的诊断界值低于诊室，本示例取平均家庭血压 135/85 mmHg。动态血压白天段均值达到 135/85 mmHg 同样视为升高。

二、降压目标值

人群	本示例推荐的降压目标	备注
一般成人高血压	低于 130/80 mmHg	能耐受时优先达标
合并糖尿病	低于 130/80 mmHg	不追求低于 120/70 mmHg
65~79 岁老年人	低于 140/90 mmHg，耐受则 130/80	起始收缩压 150 mmHg 以上
80 岁及以上高龄	低于 150/90 mmHg	站立位血压需一并评估
合并慢性肾脏病	低于 130/80 mmHg	白蛋白尿存在时更严格

三、生活方式干预

钠盐摄入控制在每日 5 g 以下，规律有氧运动每周 150 分钟以上，体重指数保持在 24 以下，男性饮酒量折算为每日酒精不超过 25 g。本示例给出的预期收缩压下降幅度为：限盐 5~8 mmHg、减重每千克 1 mmHg、规律运动 4~7 mmHg。

四、药物治疗路径

初始治疗可选用长效二氢吡啶类钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂或噻嗪类利尿剂。血压高于目标值 20/10 mmHg 者建议起始两药小剂量联合。合并蛋白尿者优先选择肾素-血管紧张素系统抑制剂。妊娠期禁用该类抑制剂。

用药后每 4 周随访一次直到血压达标，达标后每 3 个月随访一次。出现体位性低血压、血钾高于 5.5 mmol/L 或血肌酐较基线升高超过 30% 时应重新评估方案。

五、转诊提示

年龄低于 30 岁、血压突然升高伴低血钾、妊娠 20 周后新发高血压、以及规范三联用药仍不达标者，本示例建议转上级专科进一步查因。